Processo nº 0159181-97.2023.8.17.2001

AUTOR(A): S. T. B. M. D. L.
REPRESENTANTE: THIAGO MARTINS SAMPAIO DE LACERDA, PRISCILA TRINDADE DA SILVA BARROS MARTINS

RÉU: UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

SENTENÇA

R.H.

SOFIA TRINDADE BARROS MARTINS DE LACERDA menor impúbere representada pelos seus genitores **THIAGO MARTINS SAMPAIO DE LACERDA e PRISCILA TRINDADE DA SILVA BARROS MARTINS** ajuizou a presente AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS contra **UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO**, ambos qualificados.

Alega a autora, em breve síntese, que é usuária do plano de saúde demandado a aos 7 anos apresentou aumento na velocidade do crescimento, avanço de idade óssea e demais sintomas de quadro de puberdade precoce, sendo indicado o tratamento com o uso de bloqueio puberal com análogos do GnRH e hormônio do crescimento.

Afirma que possui idade óssea de 11 anos e provavelmente a sua altura final seja em torno de 1,43 cm, quando então a médica que a acompanha prescreveu o uso de GENOTROPIN (hormônio do crescimento), que deve ser mantido até que a autora alcance a idade óssea de 14 anos, e cuja dosagem deverá ser reajustada de acordo com o peso corporal.

Aduz que arcou com os valores do tratamento, mas não possui mais condições de arcar com os valores da aplicação dos hormônios e foi requerido o medicamento

ao plano réu, mas o pedido foi negado, sob alegação de que não possui caráter oncológico ou imunológico.

Diante disso, requereu a antecipação de tutela para que a operadora ré ***"seja compelida a fornecer, NO PRAZO DE 24H, a cobertura/custeio de forma integral, ininterrupta e pelo tempo que for necessário, do tratamento de saúde da parte autora, correspondente ao fornecimento de GENOTROPIN 12 MG, conforme receituário médico em anexo, e novas indicações realizadas, até o final do tratamento indicado pela médica, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); "***

Juntou documentos. Requereu condenação da ré em danos materiais e morais. Fez demais pedidos.

Decisão de id. 155873239 indeferindo a tutela de urgência requerida.

Contestação (id. 165227288) aduzindo, em síntese, a ausência de cobertura legal e contratual para o fornecimento de medicamento e que estaria excluído do rol da ANS, sendo o rol taxativo. Acrescentou que os planos somente estão obrigados a cobrir, dentro das demais regras, medicamentos no âmbito hospitalar. Impugnou, ainda, os danos morais pleiteados.

Réplica de Id 168345919.

Interposto Agravo de Instrumento, o Egrégio Tribunal de Justiça de Pernambuco entendeu pelo deferimento do pedido antecipatório de tutela para o fim de compelir a seguradora a custear o fármaco prescrito pelo médico assistente no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa (Id. 169692117).

Foram as partes intimadas para indicarem se ainda haviam provas a serem produzidas, tendo ambas manifestado interesse no julgamento antecipado e os autos foram enviados ao Ministério Público, que opinou pela procedência do pedido.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório, pelo que, **DECIDO**.

1. JULGAMENTO CONFORME O ESTADO DO PROCESSO

Entendo ser questão que dispensa dilação probatória, uma vez que os elementos presentes, inclusive a prova documental, já são suficientes para emitir a sentença antecipadamente, entendo pela aplicação do artigo 355, inciso I, do Código

de Processo Civil, a confortar o julgamento antecipado da lide, consolidado pelas seguintes orientações da jurisprudência que interpretavam dispositivo semelhante do Antigo Código de Processo Civil:

> **“Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ-4ª turma, Resp 2.832-RJ, DJU 17.9.90, p. 9.513).**
>
> **“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.” (STJ-4ª Turma, Ag 14.952-DF-AgRg, DJU 3.2.92, p. 472).**

2. DO MEDICAMENTO PRETENDIDO

A pretensão deduzida pela autora quanto ao fornecimento do medicamento Genotropin ou Omnitrope ou Criscy não comporta acolhimento porque a operadora do plano de saúde está obrigada a custear o medicamento para uso domiciliar somente quando associado a tratamento quimioterápico, o que não é o caso dos autos, pois a parte autora padece de Baixa Estatura Idiopática e Familiar (CID E34.3).

Nesse sentido, mudando o que tem que ser mudado, confira-se o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo, ***in verbis***:

"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Plano de saúde - Autora menor diagnosticada como portadora de dermatite atópica - Indicação médica para tratamento com uso do medicamento “RINVOQ DA (Upadacitinibe)” - Sentença de parcial procedência condenando a ré ao cumprimento de obrigação de fazer consubstanciada no fornecimento do medicamento - Insurgência de ambas as partes. Ré que pretende seja afastada a obrigação de fornecer o medicamento. Autora que pleiteia a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Recusa da ré em fornecer o medicamento, sob o argumento de exclusão contratual, por se tratar de fármaco de uso domiciliar - Acolhimento - Plano de saúde que somente está obrigado a custear medicamentos quando associados a tratamento quimioterápicos, ou se fornecidos em ambiente exclusivamente hospitalar (Inteligência do art. 10, VI da Lei 9656/98) - Medicamento prescrito à autora que é de uso domiciliar - Doença não neoplásica - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Ausência de obrigatoriedade de cobertura - Sentença reformada - Recurso da ré provido. Recurso da autora prejudicado. (...) O relatório médico de fls. 76, comprova que a autora foi diagnosticada como portadora de dermatite atópica, tendo-lhe sido indicado, tratamento com uso do medicamento “RINVOQ DA (Upadacitinibe)”. No exame da lide objeto deste recurso, deve ser ponderado, inicialmente, que o dever primário de prestação de serviço de saúde é do Estado, ainda assim, respeitados os limites orçamentários, pois o serviço prestado pelas operadoras de planos de saúde e seguros-saúde é suplementar, na esteira do que prescreve o art. 199, § 1°., da Constituição Federal. Não se desconhece julgados que, invocando o Código de Defesa do Consumidor, determinam às operadoras de planos de saúde e de seguros-saúde a cobertura para o fornecimento de medicamento para as mais diversas finalidades, especialmente os de alto custo e para tratamento de doenças crônicas. Contudo, as disposições do Código de Defesa do Consumidor devem ser interpretadas sistematicamente e em conformidade com o que dispõe a Constituição Federal, que, tocante à prestação de saúde, assim dispõe: Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado,

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado. Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. § 1º - As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos." Ora, se a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, a este compete a prestação de assistência plena, reservando-se às instituições privadas a participação complementar, nos termos e na forma da lei. Com efeito, no exercício da atividade autorizada pelo art. 199 da Constituição Federal, as operadoras de planos de saúde estão obrigadas a observar a lei que regula sua atividade, moldando seus contratos em conformidade com suas diretrizes, daí não estar obrigadas a conferir cobertura para os produtos e serviços nela não contemplados. Conquanto os contratos de plano de saúde e de seguros-saúde, por serem contratos de adesão e por estarem submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, se sujeitem ao dirigismo estatal, a limitação à liberdade de disciplinar a relação contratual não pode ir além das restrições expressamente impostas pela lei, sob pena de violação do princípio constitucional da livre iniciativa, daí não se cogitar de invalidade da disposição contratual que, na forma da lei (art. 10, VI, Lei nº. 9.656/98), nega ou restringe a cobertura para fornecimento de medicamento de uso domiciliar. Nesse contexto, impende destacar que o art. 10, VI, da Lei nº. 9.656/98 é expresso em excluir de cobertura pelos planos de saúde e seguros-saúde os medicamentos de uso domiciliar, à exceção daqueles indicados nas alíneas "c" do inciso I e "g" do inciso II de seu art. 12, que tratam dos medicamentos quimioterápicos, assim chamados "antineoplásicos". Além dos medicamentos antineoplásicos, em relação aos quais pouco importa a eventual possibilidade de aplicação domiciliar, há exceção também quanto àqueles de administração exclusiva por profissional da saúde, em ambiente ambulatorial ou hospitalar, ou em extensão à internação hospitalar, quando em regime de home care. Aqui, a hipótese abrange os medicamentos cujas respectivas bulas indiquem a necessidade de aplicação por profissional da saúde habilitado. Nesse contexto, havendo expressa vedação legal para a cobertura de fornecimento de medicamentos de uso domiciliar, exceção feita aos antineoplásicos, não se justifica conferir cobertura para outros medicamentos também de uso domiciliar só porque existe prescrição médica, na esteira da Súmula 102 deste Egrégio Tribunal e do CDC. Se assim o fosse, todo e qualquer medicamento que pudesse ser adquirido em farmácias, deveria ser custeado pelo plano de saúde respectivo, o que não atende à finalidade dos planos de saúde e viola flagrantemente o princípio econômico-financeiro do contrato. Assim, o plano de saúde somente está obrigado a custear medicamentos quando associados a tratamento quimioterápicos, ou se fornecidos em ambiente exclusivamente hospitalar, conforme artigo 10, inciso VI da Lei nº 9656/1998. No caso dos autos, verifica-se que, além de não se tratar de medicamento antineoplásico, não há indicação acerca da necessidade de aplicação por profissional da saúde em ambiente hospitalar ou ambulatorial, podendo o medicamento prescrito ser adquirido em farmácias comuns e administrado pelo próprio paciente. Assim, forçoso reconhecer a inexigibilidade da cobertura do medicamento em questão, que deve ser custeado pelo próprio interessado. Esse é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça: '1. Cuida-se de recurso especial interposto por RAFAEL ALBUQUERQUE MOTA DA SILVA (MENOR), com fundamento no art. 105, III, alíneas a e c, da Constituição da República, em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, assim ementado (fl. 490): SEGURO SAÚDE. *HORMÔNIO* DO *CRESCIMENTO* (SOMATROPINA). MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NAS HIPÓTESES PREVISTAS NOS ARTS. 10, VI E 12, I, 'c' e II, 'g' DA LEI Nº 9.656/98 E NO ROL DE COBERTURA DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 428/2017 DA ANS, TAMPOUCO EM PARECERES TÉCNICOS SOBRE MEDICAMENTOS E/OU MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DOMICILIAR. FORNECIMENTO. NÃO OBRIGATORIEDADE. NEGATIVA COM BASE CONTRATUAL E NORMATIVA. RECURSO DESPROVIDO. Não configurada abusividade ou ilegalidade na conduta da seguradora apelada ao recusar a cobertura do custeio do medicamento SOMATROPINA, de uso domiciliar, fora do ambiente hospitalar e ambulatorial, para o qual não está obrigada por lei ou contrato, sendo legítima a conduta baseada em expressa exclusão contratual lastreada na excepcionalidade dos Arts. 10, VI e 12, I, 'c' e II, 'g' da Lei nº 9.656/98, bem como não fazendo parte do rol de procedimentos e eventos de cobertura obrigatória listados no anexo I da Resolução Normativa nº 428/2017, tampouco nas hipóteses de cobertura elencadas no PARECER TÉCNICO Nº 26/GEAS/ GGRAS/DIPRO/2018 e no recente PARECER TÉCNICO Nº 21/GEAS/GGRAS/DIPRO/2019 sobre MEDICAMENTOS, assim como nos mais recentes PARECERES T É C N I C O S N º 2 9 / G E A S / G G R A S / D I P R O / 2 0 1 8 e N º 20/GEAS/GGRAS/DIPRO/2019 sobre os MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DOMICILIAR. Conquanto o laudo da médica assistente ateste a necessidade do tratamento precoce com a reposição hormonal da somatropina até a idade óssea de 16 anos, não se infere dos termos ali expressos risco vital a lastrear a excepcionalidade da pretensão, visando o tratamento melhorar a estatura do paciente à luz dos critérios da normalidade populacional e familiar. Os embargos de declaração opostos pela recorrente foram rejeitados (fls. 569-571). Em suas razões recursais (fls. 670-691), aponta a parte recorrente, além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao artigo 1.022, inciso II e III, parágrafo único, inciso II, bem como ao artigo 489, § 1º, inciso IV, todos do CPC, pois o "acórdão Recorrido silenciou-se também no que tange o fato do art. 10, VI da Lei 9656/98 não vedar o fornecimento de fármacos, mas apenas possibilita que as operadoras de plano de saúde insiram cláusulas de exclusão em seus contratos de adesão.' (fl. 680) Sustenta que o

medicamento *hormônio* de *crescimento* (SOMATROPINA) se encontra previsto no Anexo I, da Resolução Normativa nº 428/2017 da ANS, que trata dos procedimentos de cobertura obrigatória pelos Planos de Saúde. Argumenta que nos termos do artigo 47, do CDC, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da forma mais favorável ao segurado e que as disposições que coloquem o consumidor em exagerada desvantagem deve ser consideradas nulas, conforme dispõe o artigo 51 do CDC. Com apresentação de contrarrazões (fls. 733-741), o recurso especial foi admitido na origem (fls. 742-744), ascendendo os autos a esta Corte. Parecer do Ministério Público Federal, manifestando-se pelo conhecimento parcial do recurso especial, e, nos pontos suscetíveis de conhecimento, quanto ao mérito, pelo seu não provimento (fls. 754-764). É o relatório. DECIDO. 2. No tocante à controvérsia acerca da negativa de cobertura ao tratamento com o medicamento destinado à doença que acomete a parte autora, objeto da ação, e à legitimidade de cláusula contratual que restringe o fornecimento de medicamentos não contemplados no ROL da Agência Reguladora - ANS, essa NÃO merece acolhida. Verifica-se que o Tribunal local considerou que não ficou demonstrada ser abusiva a cláusula contratual que previa suas restrições, conforme trecho abaixo transcrito, com grifos acrescentados (fls. 485-491): [...] Cinge-se a discussão travada no feito à obrigatoriedade ou não do custeio por parte da seguradora apelada do medicamento SOMATROPINA [Genotropin], na dose de 0,9mg/Kg/dia (Saizen 12mg, Genotropin 12mg, Norditropin 15mg ou Omnitrope 15mg). No caso em apreço, os recorrentes argumentam que a criança, à época com 07 (sete) anos de idade estaria na iminência de sofrer danos irreversíveis, ante a possibilidade de sofrer perda irreparável na sua altura final, motivo pelo qual deveria começar de imediato o tratamento prescrito para repor o *hormônio* do *crescimento* em seu organismo, conforme laudo médico acostado aos autos. Ocorre que a medicação pretendida se encontra nas situações de exclusão de cobertura insertas nos itens 15.10 e 15.12 das condições gerais pactuadas (Id. 7853281), referente a fornecimento de medicamento utilizado para tratamento em domicílio, ou seja, fora do atendimento ambulatorial ou regime de internação hospitalar Ademais, de acordo com o Art. 10, VI da Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, o medicamento prescrito não possui obrigatoriedade de cobertura pelo seguro de saúde contratado, por se tratar de medicação para tratamento domiciliar não inserido no rol de obrigatoriedade de cobertura previsto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do Art. 12 da norma em referência. Com efeito, conforme previsão inserta no caput do Art. 12 da Lei nº 9.656/98, devem ser respeitadas as amplitudes de cobertura definidas no planoreferência de que trata o Art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: 1º) quando incluir atendimento ambulatorial, a cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes (inciso I, alínea "c"); 2º) quando incluir internação hospitalar, a cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar (inciso II, alínea "g"). Assim, considerando que a medicação em tela não integra as hipóteses acima previstas, não estaria a operadora legalmente obrigada a fornecê-la. Note-se, ainda, que a Resolução Normativa nº 310, de 30 de outubro de 2012 da ANS, estabeleceu regras de adesão facultativa pelas administradoras, para a oferta de medicação de uso domiciliar para os seus beneficiários, mediante a elaboração de contrato acessório, com características diferenciadas em relação aos planos de saúde individuais e coletivos, também não se enquadrando o caso dos autos aos grupos das patologias ali descritas. Da mesma forma, a medicação questionada não se encontra nas hipóteses de cobertura elencadas no PARECER TÉCNICO Nº 26/GEAS/GGRAS/DIPRO/2018 e no recente PARECER TÉCNICO Nº 21/GEAS/GGRAS/DIPRO/2019 sobre MEDICAMENTOS, assim como nos mais recentes PARECERES TÉCNICOS Nº 29/GEAS/GGRAS/DIPRO/2018 e Nº 20/GEAS/GGRAS/DIPRO/2019 sobre os MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DOMICILIAR, não fazendo parte do rol de procedimentos e eventos de cobertura obrigatória listados no anexo I da Resolução Normativa nº 428/2017. De outra banda, ainda que o laudo (Id. 7853124) da médica que assiste o apelante ateste a necessidade do tratamento precoce com a reposição hormonal da somatropina até a idade óssea de 16 anos, não se infere dos termos ali expressos risco vital a lastrear a pretensão, eis que de acordo com a referida declaração, o tratamento visa melhorar a estatura do paciente, por se encontrar no limite mínimo da normalidade populacional e bem abaixo do perfil familiar. **Ora, considerando não haver previsão obrigatória no contrato firmado entre as partes, tampouco na legislação regedora dos planos e seguros privados de assistência à saúde, resoluções normativas e pareceres técnicos dos órgãos reguladores da matéria, nem razão suficiente a comprovar risco maior à saúde e/ou à vida do paciente, a ensejar a excepcionalidade do provimento jurisdicional, de modo a impor à operadora o fornecimento da medicação pretendida, tenho que carece ao pleito recursal elementos imprescindíveis ao seu acolhimento,** não merecendo reparo o entendimento firmado no juízo de base. [...] Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação para manter inalterada a sentença combatida. É como voto. (grifou-se) Do acima, se extrai que a conclusão a que chegou o Tribunal a quo está em conformidade com recentes precedentes unânimes das turmas de direito privado, é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021)" (REsp n. 1.692.938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021). (...) Nessas circunstâncias, deve ser reformada a r. sentença, afastando-se a obrigação, por parte da operadora, de

fornecer o tratamento com o medicamento pleiteado. Ante o provimento do recurso, invertem-se os ônus de sucumbência, devendo a autora arcar com os honorários advocatícios fixados na sentença, observada a gratuidade da justiça. Isto posto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso da ré, ficando prejudicado o recurso adesivo, interposto pela autora, nos termos da fundamentação acima." (TJSP, Apelação Cível nº 1003815-07.2022.8.26.0296, 6ª Câmara de Direito Privado, Relator MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES, j. 22/11/2023).

Portanto, acompanhando o entendimento da Corte Paulista, não há obrigatoriedade de custeio do medicamento e tão pouco ilegalidade a ser reparada à título de danos morais.

3. DO DISPOSITIVO

3. DO DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido.

Condeno ainda a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, este último que arbitro em 10% do valor da causa. Vistas ao Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Restam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Publique-se, registre-se e Intime-se.

Recife, 19 de dezembro de 2024

CARLA DE VASCONCELLOS R M DE AQUINO

Juíza de Direito

Assinado eletronicamente por: CARLA DE VASCONCELOS RODRIGUES
19/12/2024 07:30:35
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 191591341

24121907303505600000186784027

IMPRIMIR GERAR PDF